SDD 166 Sujet n°2

Spécialité : Cardiologie

Date : 11/03/2024
Auteur : Gauthier Beuque
Relecteur(s) : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie, ECN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie diagnostique
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie pertinente de la prise en charge
Item(s) en lien avec la station	237 - palpitation 232 - fibrillation atriale
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 166 - tachycardie SDD 165 - palpitations
Matériel nécessaire à la station	Imprimante pour : - Fiche carnet d'automesure tensionnelle - ECG
Contexte de la station	Consultation en cabinet de cardiologie pour une tachycardie asymptomatique

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes un interne en médecine générale en stage chez le cardiologue.
Vous recevez le patient monsieur Gérard, âgé de 72 ans au cabinet de cardiologie qui est adressé par son médecin traitant pour tachycardie.
PA 154/97 mmHg, fréquence cardiaque 123/min, 37,1 °C, poids : 99 kg, taille : 175 cm, IMC 32 kg/m2

Vous ne connaissez pas encore ses antécédents. Le patient est strictement asymptomatique. Il vous remet toutefois une carte d'automesure tensionnelle que vous lui avez demandé de réaliser avant de venir.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Faire le diagnostic de cette tachycardie avec l'iconographie présente
- Rechercher et énoncer les facteurs prédisposants à cette pathologie chez le patient
- Réaliser un interrogatoire et utiliser les éléments à votre disposition pour stratifier le risque liée à la pathologie présentée par le patient
- Proposer une prise en charge thérapeutique.

Vous ne devez pas :
- Rédiger l'ordonnance ;
- Réaliser un examen clinique ;
- Réaliser un interrogatoire complet
- Analyser de manière détaillée l'iconographie présentée

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)	
Décrit un électrocardiogramme 12 dérivations	1 pt
Énonce le diagnostic de fibrillation atriale	1 pt
Citer comme facteur prédisposant l'HTA	1 pt
Enoncer l'âge comme facteur prédisposant	1 pt
Énonce l'obésité ou le SAOS comme facteurs prédisposants	1 pt
Recherche une dysthyroïdie ou la prise de produits excitants (café, cocaïne, OH)	1 pt
Rechercher les antécédents cardiovasculaires (au moins 2 parmi les suivants) : - Infarctus - AVC, - AIT, - Insuffisance cardiaque - Dysfonction VG - Coronaropathie - AOMI - Embolie périphérique	1 pt
Recherche un diabète de type 2	1 pt
Donne un score de CHA2-DS2-VASC à 7	1 pt
Mise en place d'une anticoagulation d'emblée	1 pt
Énonce une anticoagulation par AOD	1 pt
Énonce contrôler le DFG ou recherche un antécédent d'insuffisance rénale	1 pt
Mise en place d'un ralentisseur de la fréquence cardiaque (bêta bloquant)	1 pt
Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)	
2. APTITUDE À QUESTIONNER	1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS — 1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE — 1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES — 1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques) — 1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL (max 20 items)	**… / 15 points**

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)
Toujours rechercher des contre-indications à la mise en place des traitements.
De plus, la recherche d'antécédent (bien qu'étant de l'interrogatoire) et nécessaire au calcul du CHAD2-DS2-VASC

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Votre médecin généraliste a découvert un rythme cardiaque rapide, sans que vous ayez le moindre symptôme.

Plan de la station ECOS :

Le patient s'installe en face du bureau du médecin. Lorsque l'étudiant évalué demande la réalisation d'un ECG : lui remettre l'ECG

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

"Bonjour docteur, je suis envoyé par mon médecin traitant qui m'a demandé de vous montrer ce papier."

Identité du patient :

Homme, Gerard, 78 ans, poids : 99 kg, taille : 175 cm (obèse)

Mode de vie :

Retraité, marié, autonome à domicile sans aides, vit avec sa femme, aime la peche, n'a pas d'enfants. A fumé 10 cigarettes par jour entre ses 20 et 40 ans. Ne connait pas ses allergies. Consomme 1 verre de vin rouge par jour.

Comportement global :

Détendu, blagueur, ne comprend pas le motif de la consultation. Parfaitement adapté.

Antécédents personnels :

Infarctus du myocarde à l'âge de 55 ans, diabète de type 2 découvert à l'âge de 55 ans, AVC sylvien gauche à l'âge de 70 ans sans séquelle
Absence d'asthme, absence de BPCO
Absence d'antécédent hémorragique
HTA non traité.

Antécédents familiaux :

Infarctus chez le frère (à l'âge de 50 ans) et chez le père (alors âgé de 65 ans)
Absence d'antécédent familial hémorragique

Médicaments :

Traitement de fond : aspirine 100 mg, atorvastatine 80 mg

Symptômes positifs :

Strictement asymptomatique

Constantes :

PA 154/97 mmHg, fréquence cardiaque 123/min, 37,1 °C, poids : 99 kg, taille : 175 cm, IMC 32 kg/m2

Donnée complémentaire :

Consultation avec le médecin traitant il y a 1 semaine qui vous redirige vers un cardiologue. Vous remettez dès l'arrivée, la fiche d'automesure tensionnelle.

NE PAS OUBLIER DE METTRE LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LE DRIVE

Questions de relance :

Si l'étudiant ne parle pas des traitements à mettre en place, dire : "quels traitements dois-je prendre désormais, en plus de mes 2 comprimés ?"

ECOS TACFA

FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

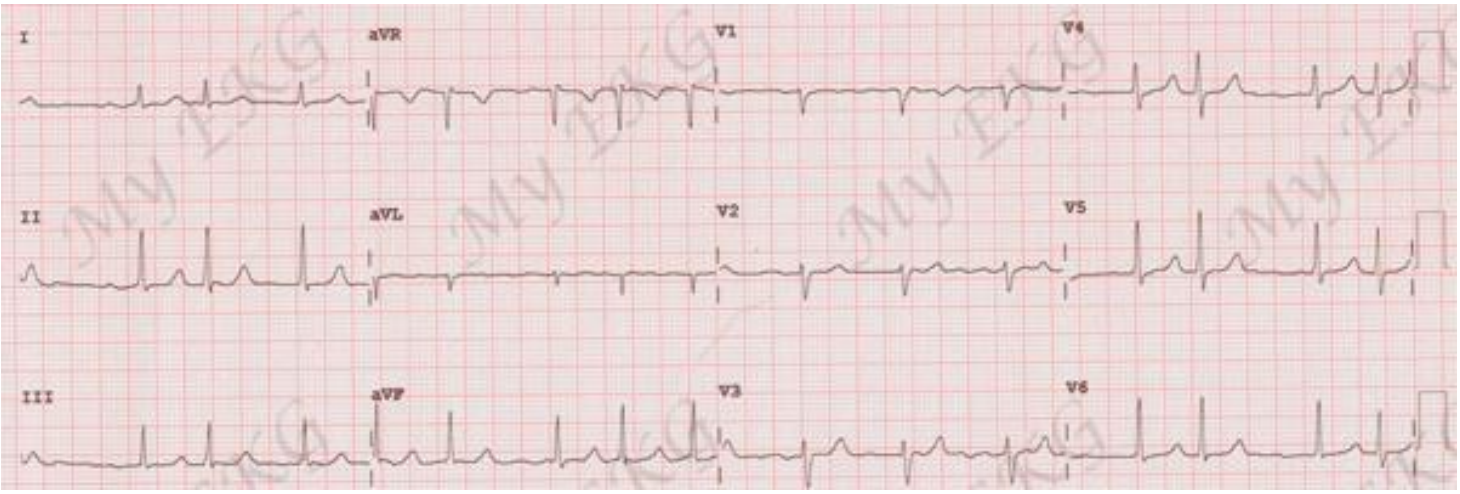
Plan de la station ECOS :

Bureau séparant patient/médecin. ECG situé à côté du bureau.
Lorsque l'étudiant demande la réalisation d'un ECG, le patient lui remet l'ECG en main propre directement.

Matériel nécessaire à la station :

- ECG

Documents présents dans la station :

- ECG imprimé et fiche d'automesure tensionnelle montrant une HTA

ANNEXE :